

COMPLICACIONES VÁLVULAS PROTÉSICAS

Samuel Del Castillo García, Laura Álvarez Roy, Carlos Minguito Carazo, Guisela María Flores Vergara, Miguel Rodríguez Santamarta, Tomás Benito González, Carlota Hernández Díaz, Silvia Prieto González, Carmen Echevárren Palacios.

INTRODUCCIÓN

Cada vez son más los pacientes portadores de válvulas protésicas debido tanto al envejecimiento de la población como a la mejora tanto en las técnicas quirúrgicas como en los tipos de prótesis disponibles. Entre las complicaciones valvulares en estos pacientes, nos podemos encontrar desde una trombosis aguda de una prótesis, hasta complicaciones embólicas o infecciosas.

DIAGNÓSTICO

En lo que se refiere a la trombosis de una prótesis valvular, más frecuente en mecánicas, la clínica principal es la aparición de insuficiencia cardíaca progresiva que puede evolucionar en pocas horas hasta el desarrollo de shock cardiogénico si se trata de una trombosis obstructiva, la exploración física también puede mostrar la aparición de un soplo de novo.

En estos pacientes una anamnesis detallada sobre el tratamiento anticoagulante que reciben, procedimientos que se hayan realizado recientemente, así como los niveles de anticoagulación en la analítica sanguínea nos pueden orientar hacia esta patología.

En la analítica sanguínea podemos encontrarnos datos de hemólisis como elevación de la LDH, anemia o hiperbilirrubinemia. La radiografía de tórax nos será útil para mostrar signos de insuficiencia cardíaca.

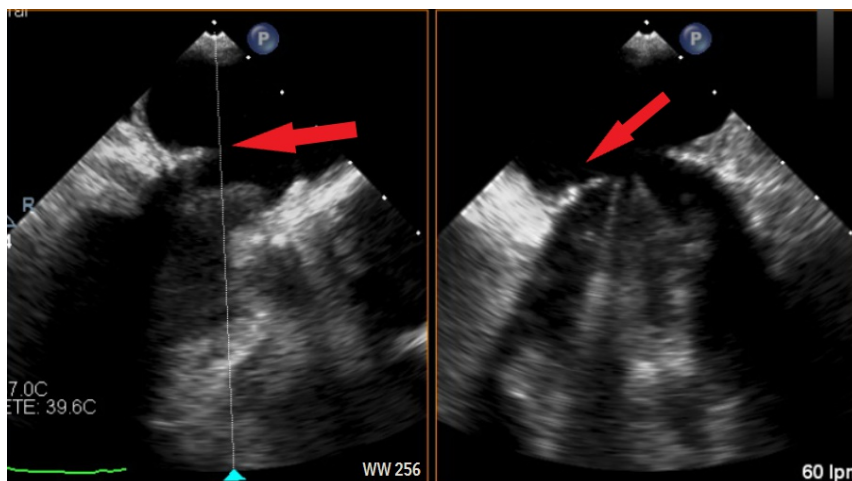
Al igual que en la endocarditis infecciosa la ecocardiografía es la principal herramienta diagnóstica, tanto la ecocardiografía transtorácica (aunque en ocasiones su sensibilidad se ve reducida por una mala visualización de los discos) como la ecocardiografía transesofágica (cuando el especialista así lo considere). La escopia nos es muy útil para valorar la movilidad de los discos protésicos.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

El manejo de estos pacientes es difícil. En lo que respecta a la actitud a tomar en urgencias, lo más importante es el soporte hemodinámico de estos pacientes, algunos de ellos desarrollan situación de shock cardiogénico en pocas horas, por lo que debemos estar alerta ante una posible situación de inestabilidad hemodinámica que pueda precisar de soporte con fármacos vasoactivos, así como medidas de soporte respiratorio. Así mismo debemos tratar la insuficiencia cardíaca secundaria con tratamiento diurético, oxigenoterapia y tratamiento vasodilatador si precisase.

Ante la sospecha clínica de una trombosis protésica se debe avisar al especialista, quién indicará, tras las pruebas diagnósticas oportunas, la actitud a seguir.

Otras posibles complicaciones de los pacientes con prótesis valvulares son la endocarditis infecciosa (ya detallada en el apartado anterior), complicaciones embolígenas derivadas de la presencia de trombo en la válvula o las dehiscencias periprotésicas.



Flecha Roja: Trombosis sobre válvula protésica mitral

BIBLIOGRAFÍA

- Habib G, Lancellotti P, Antunes MJ, Bongiorni MG, Casalta JP et al. 2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis. The Task Force for the Management of Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2015; 36(44):3075–3123.
- López Fernández T, Rosillo Rodríguez S, Gemma D. Valvulopatías. Lesiones de las válvulas nativas y de las prótesis valvulares. En: Nuñez-Gil I, Viana-Tejedor A. Cardio Agudos. 1º ed. 2015. Madrid: CTO editorial; 2015. p. 225- 237.

